

Налоксон

Конкурентный антагонист μ -опиоидных рецепторов · собственной активности не имеет

ФОРМА ВЫПУСКА

0,04 % · 1 мл = **0,4 мг**
0,4 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Вытесняет агонист с μ -рецептора и восстанавливает чувствительность дыхательного центра к углекислому газу. Агонистической активности не имеет. Начало действия при внутривенном введении — секунды. Период полувыведения 30–80 минут, клинический эффект 30–90 минут. Большинство опиоидов действует дольше налоксона, поэтому ренаркотизация закономерна.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Отравление опиатами и опиоидами, взрослый (ЧД < 12 и/или нарушение сознания)	0,4 мг (1 мл)	в/в
При недостаточном эффекте	0,4 мг (1 мл) повторно	в/в
Прил. 44: нестойкий эффект	0,4–0,8 мг , при необходимости повторно каждые 10–15 мин	в/в
Дети	0,01–0,02 мг/кг (0,025–0,05 мл/кг); повторно в той же дозе	в/в

Критерий эффекта — восстановление дыхания: ЧД $\geq$ 12 в минуту и приемлемый SpO₂. Восстановление сознания критерием не является. Вводить только после обеспечения проходимости дыхательных путей, при SpO₂ $\geq$ 90 %.

НАСОС 31-Р в Алгоритмах не описан; капельная инфузия (⅓ болюсной дозы в час) — стационарная задача

ОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Полная отмена опиоидного действия у зависимого пациента провоцирует абстиненцию: рвота в незащищённые дыхательные пути, выброс катехоламинов, некардиогенный отёк лёгких, аритмия
- Ригидность грудной клетки при интоксикации фентанилом налоксоном не устраняется; требуется нейромышечная блокада
- При смешанном угнетении (этанол, бензодиазепины) налоксон устраняет только опиоидный компонент
- Ренаркотизация: период действия героина — часы, метадона — сутки; эвакуация обязательна
- Введение на фоне гипоксической энцефалопатии может ухудшить состояние: судороги, отёк мозга, отёк лёгких (прил. 44)

ТАКТИКА

- Вентиляция — основное лечение; налоксон позволяет прекратить ручную вентиляцию
- Порядок действий: проходимость дыхательных путей → ИВЛ 100 % кислородом → SpO₂ $\geq$ 90 % → налоксон
- После введения: контроль рвоты, аускультация лёгких (некардиогенный отёк через 10–30 минут), ЧД, ритм
- Эвакуация в стационар; при отказе — актив в ОНМПВиДН (если вводился налоксон)